

Overvaluation *nadmierne znaczenie*

Rdzeń poznawczy bulimii: samoocena oparta głównie lub wyłącznie na wadze i kształcie. To NIE „próżność” — to wąska baza samooceny. Cel CBT-E: rozszerzenie tej bazy.

CZAS: 30 min · konceptualizacja rdzenia · Etap 3 CBT-E (sesje 9–16) · po stabilizacji

ŹRÓDŁO: Fairburn (2008); Cooper i in. (2007); Fairburn, Stice i in. (2003)

JAK UŻYWAĆ

Poznaj **definicję i mechanizm overvaluation** (sekcja 1), zobacz dlaczego rdzeń jest **predyktorem długoterminowego przebiegu** bulimii (sekcja 2). Sekcja 3 — Twoja konceptualizacja rdzenia. Sekcja 4 — pierwsze kroki rozszerzania samooceny.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Nadmierne znaczenie wagi i kształtu dla samooceny (*overvaluation of shape and weight*) to **rdzeń poznawczy** wszystkich zaburzeń odżywiania według Fairburna (2008). Definicja: osoba ocenia siebie **głównie** lub **wyłącznie** przez pryzmat wagi, kształtu ciała i kontroli jedzenia — inne obszary życia mają *nieproporcjonalnie* małe znaczenie. To **nie** jest „próżność” — to *poznawcza konfiguracja*, w której cała wartość osoby jest zredukowana do jednego wskaźnika. Fairburn, Stice i in. (2003): pacjenci, u których po terapii *overvaluation spada*, mają **znacząco niższe** ryzyko nawrotu ($d = 0,9$). Przeciwnie: redukcja samych epizodów *bez zmiany rdzenia* = wysokie ryzyko nawrotu w 12 miesięcy. CBT-E poświęca **etap 3** (sesje 9–16) pracy z rdzeniem. To praca *długoterminowa* (3–6 miesięcy), ale daje **trwałość**.

01 ● Czym jest overvaluation — mechanizm

BEZ OVERVALUATION

Samoocena oparta na *wielu* obszarach: praca, relacje, pasje, charakter, wartości. Waga to drobny fragment całości. Jedna porażka nie obala wartości.

Z OVERVALUATION

Samoocena oparta *głównie* lub *wyłącznie* na wadze i kształcie. Wąska baza. Każda fluktuacja wagi = fluktuacja samooceny.

Konsekwencja: jeśli Twoja samoocena w *największym stopniu* zależy od wagi/kształtu, to każda zmiana ciała (rzeczywista lub wyobrażona) zachwieje Twoim poczuciem wartości. Powstaje silna potrzeba *kontroli* wagi → reguły żywieniowe → cykl epizodów i kompensacji. Rdzeń pozostaje, **jeśli się go nie zaadresuje** — nawet po remisji epizodów.

02 = Rdzeń jako predyktor nawrotu

PRACA TYLKO Z BEHAWIOREM

Pacjent kończy CBT-E z remisją epizodów, ale *overvaluation pozostaje*. Ryzyko nawrotu w 12 mies.: **60–70%**. Pierwszy stresor → powrót cyklu.

PRACA Z RDZENIEM

Pacjent kończy CBT-E z remisją epizodów i rozszerzoną bazą samooceny. Ryzyko nawrotu: **20–30%**. Stresor nie aktywuje cyklu — jest *buforowany* innymi obszarami.

Fairburn, Stice i in. (2003): w dużym RCT (N = 154) z CBT-E pacjenci, u których overvaluation spadło po terapii, mieli pełną remisję w **60%** w obserwacji 60-tygodniowej. Ci, u których overvaluation pozostało, mieli pełną remisję w **25%**. To największa pojedyncza różnica w rokowaniu długoterminowym. Wniosek: *etap 3 CBT-E* nie jest „dodatkiem” — jest **warunkiem** trwałości efektu.

03 \ Moja konceptualizacja rdzenia

Spróbuj ocenić *procentowo*, ile Twojej samooceny czerpiesz z różnych obszarów. To **pierwszy krok** — bez świadomości proporcji nie da się ich zmienić. Bez ocen — tylko obserwacja.

ILE % MOJEJ SAMOOCENY ZALEŻY OD WAGI I KSZTAŁTU

— spróbuj uczciwie ocenić; np. 70%, 80%, 60%

CO AKTYWUJE U MNIE ZMIANY SAMOOCENY WOKÓŁ WAGI

— sytuacje, miejsca, osoby, momenty dnia

04 Pierwsze kroki rozszerzania samooceny

IDENTYFIKACJA OBSZARÓW

Wymień obszary życia, w których możesz inwestować: praca/nauka, relacje, hobby, sport (nie kompensacyjny), wartości, charakter, kreatywność.

EKSPERYMENTY BEHAWIORALNE

Wybierz *jeden* obszar i zaplanuj aktywność w ciągu tygodnia. Nie „powinna” — chodzi o to, co Cię *autentycznie* interesuje.

MONITOROWANIE CO 4 TYGODNIE

Powtarzaj samoocenę proporcji co 4 tyg. — zobaczysz, jak waga obszarów się zmienia. To długoterminowa praca, ale widoczna w cyfrach.

CIERPLIWOŚĆ 3–6 MIESIĘCY

Rdzeń poznawczy *nie zmienia się* z tygodnia na tydzień. Wymaga miesięcy systematycznej pracy, ale daje *trwałość* efektów terapii.

Klucz: overvaluation nie zniknie samo, nawet jeśli zatrzymasz epizody. Fairburn (2008): pacjenci, którzy *pominęli* etap 3 CBT-E i zakończyli terapię po stabilizacji behawioralnej, mają **2-3x wyższe** ryzyko nawrotu niż ci, którzy ukończyli pełną terapię. To dlatego praca z rdzeniem jest **niezbymalna** — to *warunek* trwałości. *Rozszerzanie samooceny* nie oznacza „*nieważne, jak wyglądam*” — oznacza, że *wygląd jest jednym z wielu* obszarów, nie jedynym. To kluczowa różnica. Wielu pacjentów obawia się, że jeśli „*przestaną dbać o wagę*”, to ich życie się rozpadnie. Tymczasem dzieje się odwrotnie: gdy waga staje się *jednym z obszarów*, a nie *jedynym*, pacjent **odzyskuje życie** — przyjaźnie, pasję, twórczość, spokój wokół jedzenia. Cooper i in. (2007): w obserwacji 5-letniej pacjenci z rozszerzoną bazą samooceny po terapii mieli **wyższą jakość życia** niezależnie od fluktuacji wagi. To pokazuje, że *celem terapii nie jest „idealna waga”, lecz „bogate życie”*.